

Información Paciente

Nombre : Matías Nicolás Calvuen Rivera
Edad : 20a 3m 26d
Dirección : Pje Cerrto La Piramide 1420

Rut : 21.079.458-1
Fecha Nacto: 01/08/2002
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0827700
Sexo : Masculino
Teléfono : 948120252

N° Epicrisis
331677

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 14/11/2022 02:23
Fecha Egreso : 27/11/2022 14:11

Días Estadía: 13

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

politrauma

Comorbilidades

Procedimientos

23/11/2022 - Instalación Catéter Venoso Central

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

MATIAS CAVUEL RIVERA
EDAD 20 AÑOS
RUT: 21.079.458-1
FI CASR: 14/11/22
FI UCI: 14/11/22
FE UCI: 27/11/22
FE CASR: 02/12/22

ANTECEDENTES
Consumo de marihuana

MOTIVO DE INGRESO
Colisión moto v.s auto (conductor con casco) ¿ expulsado 10 mts
SCORE: Marshall II / SOFA 8 / APACHE II 16

EVOLUCION
Paciente ingresa a UCI por Traumatismo Múltiple en contexto de colisión en moto (conductor con casco) que sale eyectado 10 mts.
Al ingreso con excitación psicomotriz (sedación) ; decide IOT/ARM y realiza estudios PAN Tomografía - TC ENCEFALO (HSD izquierdo laminar / Fractura temporal derecha / HSA difusa (desplazamiento línea media 0.4 mm. TC TORAX (Fx costales múltiples - 1 a 3er arco costal posterior derecho, 2 a 4to arco costal anterior derecho, 6to arco costal posterolateral derecho / contusiones pulmonares / hemo-neumotórax derecho / laceración de parénquima pulmonar). TC PELVIS (Fractura apófisis espinosa T1-T2).

Valorado por Cirugía se coloca tubo pleural derecho aspirativo con RX TORAX (in situ) ¿ seguimiento de fracturas costales múltiples / contusiones pulmonares, Traumatología (fractura no desplazada ¿ indica inmovilización con cabestrillo), Neurología (medidas neuroprotectoras / sin conducta Neuroquirúrgico) se mantiene en observación y plan de TC ENCEFALO / TORAX / ABD - PELVIS control.

Fecha Última Actualización: 02-12-2022 13:42:51

Página 2 de 4

Al ingreso a UCI bajo sedoanalgesia SAS 1-2, ventilando en IOT/ARM VCV ¿ TAP derecho debito hemático 700 ml ¿ aspirativo, hemodinámicamente inestable evoluciona con shock ¿ requerimiento expansión con cristaloides / DVA ¿ evidencia descenso de Hto 30 /Hb 10.8 (al ingreso Hto 42/ Hb 14) sin conducta para transfusión. Coloca CVC (YAD) - RX TORAX (in situ) / TAM RD. Evoluciona con ascenso de CPK 5662 ¿ RABDOMIOLISIS, sin alteración de función renal.

EXAMEN FISICO:

TA 90/56 FC 134 SAT 97%

Pupilas isocóricas ¿ reactivas, mucosas orales con TET, campos pulmonares hipoventilación derecha ¿ presencia de TAP derecho aspirativo (hemático 700 ml), ruidos cardiacos rítmicos sincrónicos - taquicardico, crujido óseo en clavícula derecha. Abdomen blando depresible RHA disminuidos, extremidades simétricas. Al ingreso con SAS 3 responde a órdenes simples.

ESTUDIOS:

TC de cerebro de control: contusiones, + HSA difusa, mayor a izquierda y en cisterna interpeduncular, mínimo HSD agudo izquierdo, línea media con desplazamiento a derecha de 4mm.

TC TORAX: Fx temporal derecha, Fx de tercio medio- distal clavícula derecha / Fx de 1 a 3er arco costal posterior derechos /Fx de 2 a 4to arco costal anterior derecho / Fx de 6to arco costal posterolateral derecho

DIAGNOSTICOS INGRESO UCI:

TRAUMATISMO MULTIPLE

TEC MODERADO Marshall II

Contusión hemorrágica temporal izq / Hematoma subdural laminar izq

HSA difusa

Fractura de escama temporal derecha

TRAUMATISMO DE TORAX CERRADO

Hemoneumotórax derecho (Tubo pleural derecho)

Contusión pulmonar derecha / laceración pulmonar LSD

Fractura arcos costales derechos (1/2/3/4/6)

Fractura tercio medio - distal clavícula derecha

Fractura apófisis espinosas T1-T2

TRAUMA RAQUIDEO

Fx de apófisis espinosas T1/ T2

EVOLUCION / INTERCURRENCIAS:

Shock

EVOLUCION

- HDN: durante su estancia en UCI, con req de NAD hasta 0.06mcg/kg/min en manejo de shock inicial, se desteta de DVA a las 24 hrs, tras extubación programada, pero debe reiniciarse en contexto de aspiración masiva y reintubación, tras lo cual se suspenden a las 48 hrs, sin nuevos req de NAD durante días sucesivos. Durante su estancia, requiere Tx GR 1 U, sin nuevos requerimientos, con Hb adecuada posterior a ello.

- RESP: ingresa intubado a UCI. Se inicia despertar a las 24 hrs con rápido decalaje de sedoanalgesia, logrando extubación programada el 15.11 a las 12:30. Durante la noche de ese día, presente evento de emesis con aspiración, por lo que requiere reintubación dado mecánica y alteración de intercambio. Post TOT, con mejoría en gases. Se mantiene intubado, principalmente por delirium de difícil manejo, con req de Propofol, Fentanilo, Dexmedetomidina + Haloperidol y Metadona. Se logra suspender Dexmedetomidina, titulando a la baja Propofol, con lo que se extuba el viernes 25.11, sin incidentes. Sin alteraciones de intercambio, PAFI am en 283. Neumotorax en resolución, evaluado por equipo trauma, se retira pleurostomía el 27.11

- QX: Trauma toracico cerrado con Fx costales derechas (1/2/3/4/6) + Laceración LSD + Hemoneumotorax derecho con req de Pleurostomía. Pleurostomía con disminución progresiva de débitos. TC TAP del 23.11 informado como: "Leve disminución en la cuantía del neumotórax derecho; Leve derrame pleural bilateral de predominio izquierdo; Foco de laceración pulmonar en el lóbulo superior derecho; Focos de condensación pulmonares bilaterales en lóbulos inferiores, probablemente determinado por una neumopatía de etiología inflamatoria - Infecciosa.". Evaluado por Equipo de Trauma, retiran Pleurostomía sin incidentes.

- NCX: TEC Moderado a su ingreso, sin req de captor de PIC. Rápido despertar, delirioso, sin focalidad neurológica. TC Cerebro control con lesión en cuña fronto-temporal izquierda. NCx, solicitan nueva imagen control el 27/11 donde TC cerebro:

Fecha Epicrisis : 02/12/2022 13:42

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 02-12-2022 13:42:51

Página 3 de 4

cambios post contusiones fronto/temporal derecha, con leve hipodensidad, sin edema. Fracturas sin cambios. Sin indicación qx por nc. Control ambulatorio 1 mes post alta pasillo 9 CDT.

- INFLAMATORIO: Inicialmente con AMS por sospecha de Neumonía aspirativa, que se rota a Meropenem por evento de aspiración posterior a extubación, completando 10 días de tto ATB. PCR en descenso 138-121. RB 9370-9980. Sin nuevos requerimientos de antibióticos

- RENAL: Sin alteraciones de función renal durante su estancia. Requiere cargas de K en contextos de hipokalemia, hoy ELP adecuados

- NUTRICIONAL: Reg enteral bien tolerado, evaluado por fono audiológica sin restricción de consistencia para su alimentación vía oral.

- NEUROLÓGICO: paciente evoluciona con delirium de difícil manejo, poco conectado que se interpreta como abstinencia. Se titulan sedantes a la baja logrando adecuada conexión. Se decide alta y control ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

Politraumatizado - Traumatismo Múltiple
Tec Moderado Marshall II
Contusión Hemorrágica Temporal Izq / Hematoma Subdural Laminar Izq
Hsa Difusa
Fractura De Escama Temporal Derecha
Traumatismo De Torax Cerrado
Hemoneumotórax Derecho (Tubo Pleural Derecho)
Contusión Pulmonar Derecha / Laceración Pulmonar Lsd
Fractura Arcos Costales Derechos (1/2/3/4/6)
Fractura Tercio Medio - Distal Clavícula Derecha
Fractura Apófisis Espinosas T1-T2

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

bien
afebril
alimentándose por vía oral en buenas condiciones

Plan Post Alta

Control ambulatorio 1 mes post alta pasillo 9 CDT. con neurocirugía.
Control en consultorio en 1 semana para ajuste de psicofarmacos (derivar a cosam)
Paracetamol 1 gr c/8 hr vía oral por 7 días
Haloperidol 1 mg - 1mg - 3 mg (C/8 hrs) vía oral, a permanencia hasta ajuste por consultorio (cosam)
Diazepam 5 mg - 5 mg - 10 mg a permanencia hasta ajuste por consultorio (cosam)
Acudir a servicio de urgencia en caso de fiebre, náuseas vómitos o dolor intenso

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 02/12/2022 13:42

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:18

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

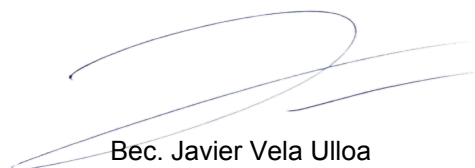
ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 02-12-2022 13:42:51

Página 4 de 4

INTERNO



Bec. Javier Vela Ulloa
Becado/Residente



Gonzalo Núñez Muñoz
Médico Tratante (Staff)